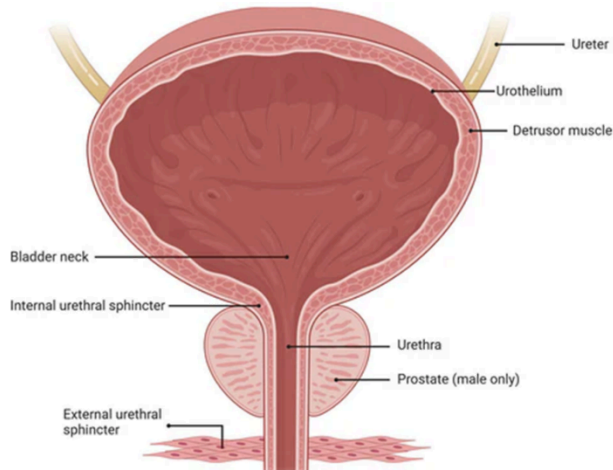
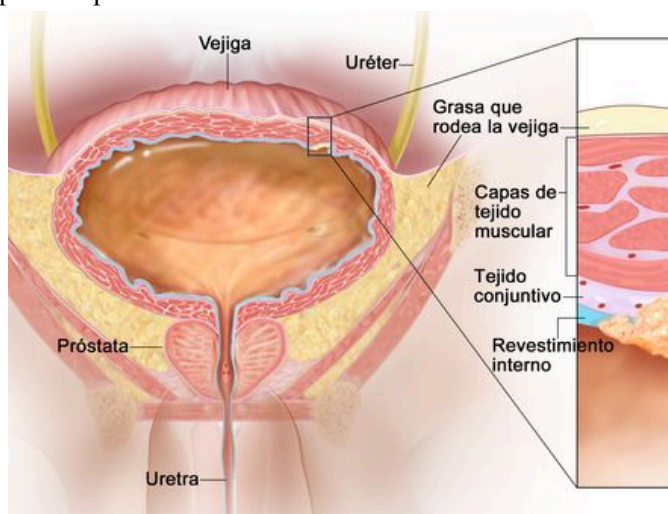




NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: <i>CISTOSTOMÍA</i>			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN) Este procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga, a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior y así evitar el daño renal.			
1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN). ANATOMÍA			
 The diagram illustrates the male urinary system. At the top, two yellow tubes represent the ureters entering the bladder. The bladder is shown as a large, muscular sac. Labels include: Ureter, Urothelium (inner lining), Detrusor muscle (muscular wall), Bladder neck (lower part of the bladder), Internal urethral sphincter (muscle at the neck), Urethra (tube leading from the bladder), Prostate (male only) (gland below the bladder), and External urethral sphincter (muscle at the base of the urethra).			
La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. Con una capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 ML.			
La vejiga posee 3 porciones:			

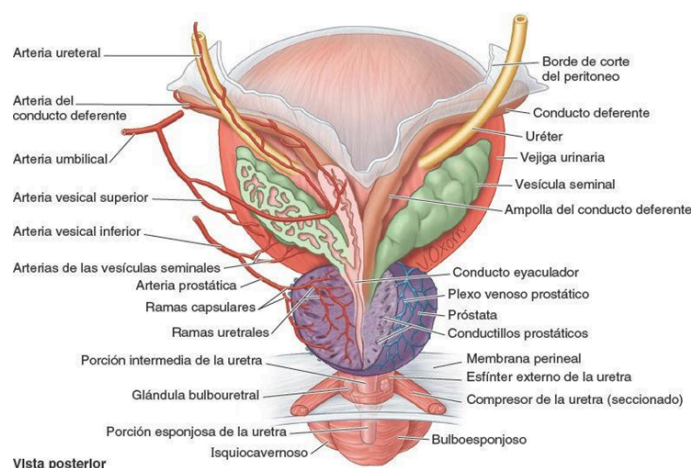
- o **Cuerpo:** Dónde la orina es recolectada.
- o **Fondo (Base):** Contiene al trigono vesical.
- o **Trígono Vesical:** Donde se localiza la uretra.

A su vez se compone por 3 capas:



- **Capa Serosa:** Se compone de tejido conectivo alveolar.
- **Capa Muscular:** Formada por 3 capas de fibras musculares lisas: Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa.
- **Capa Mucosa:** Compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente.

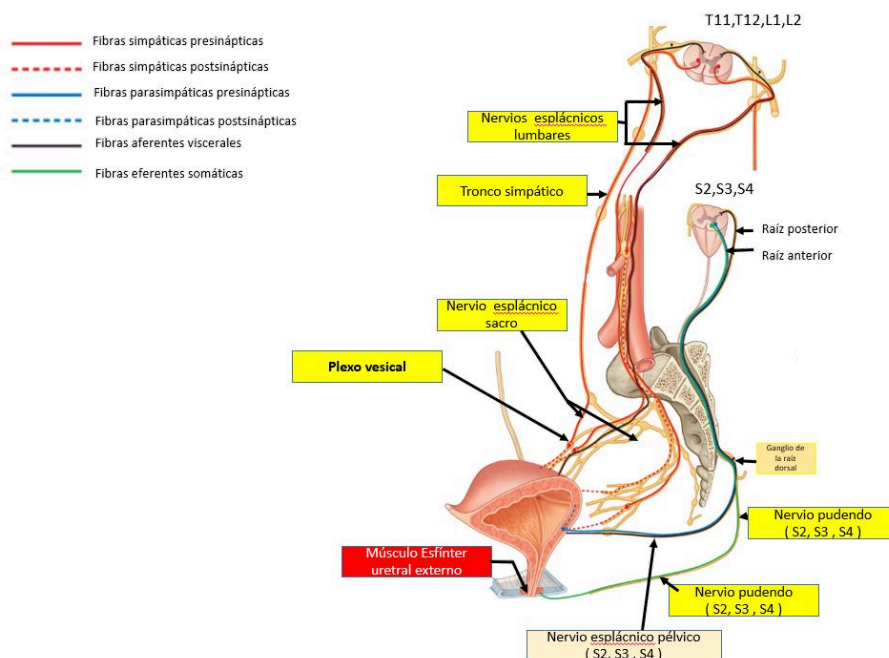
IRRIGACIÓN.



Es drenada por las **venas ilíacas internas**, y tanto en hombres como en mujeres, los vasos linfáticos de las caras supero laterales de la vejiga desembocan en los **ganglios linfáticos ilíacos externos**

INERVACION

Involucra el sistema nervioso simpático y parasimpático



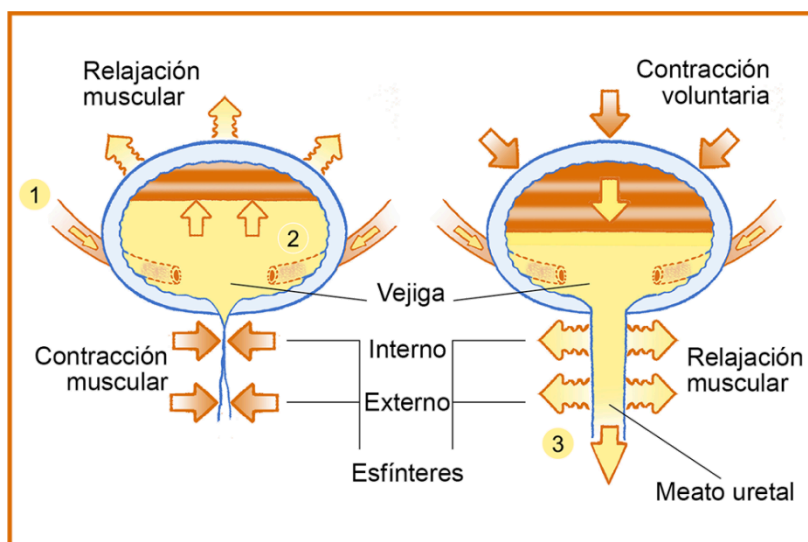
1. Las fibras simpáticas presinápticas para la vejiga urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal a través de los nervios espláncnicos lumbares pasando por el tronco simpático lumbar, plexo hipogástrico superior y nervios hipogástricos hacia los plexos vesicales (pélvicos). Es un subplexo del plexo hipogástrico inferior, de ahí envían fibras autónomas postsinápticas a las paredes de la vejiga urinaria.
2. Las fibras parasimpáticas presinápticas para la vejiga urinaria se originan en las neuronas de los segmentos sacros de la médula espinal S2-S4 y pasan desde los ramos anteriores de los nervios espinales sacros, a través de los nervios espláncnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores, hasta la vejiga urinaria.

RELACIONES DE LA VEJIGA:

- **PARTE ANTERIOR:**
 - Sínfisis del pubis
 - Espacio prevesical de Retzius.
 - Músculos de la pared abdominal
 - Fascia umbilicoprevesical
 - Uraco

- Vasos umbilicales obliterados
- **PARTE INFERIOR:**
 - Músculo elevador del ano
 - Músculos internos de la pelvis
- **PARTE POSTERIOR:**
 - Tiene el fondo de saco vésico rectal de Douglas y la Ampolla rectal.
- **PARTE SUPERIOR:**
 - Uréteres, Conductos Deferentes y Vesículas Seminales.

FISIOLOGIA



Los músculos de la vejiga que permiten el control voluntario de la micción y permiten 2 funciones: 1) la sensación que permite que reconozcas que tu vejiga está llena y debe ser vaciada y 2) el control motor que permite que puedas orinar voluntariamente.

Primero, como la pared vesical se estira cuando está llena o próxima a su máxima capacidad, existen señales que son transmitidas a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo detrusor, el cual es una capa de la pared vesical constituida por fibras de músculo liso que son ordenadas en fascículos longitudinales, circulares o en espiral, esta señal estimulará a la vejiga para expulsar orina a través de la uretra, luego, estas sensaciones dentro de la vejiga serán transmitidas al sistema nervioso central (SNC) por medio de fibras aferentes viscerales generales (AVG). Mientras las fibras aferentes en la cara superior de la vejiga siguen el curso de los nervios simpáticos eferentes hasta el SNC, las fibras aferentes en la porción inferior siguen a las fibras parasimpáticas eferentes.

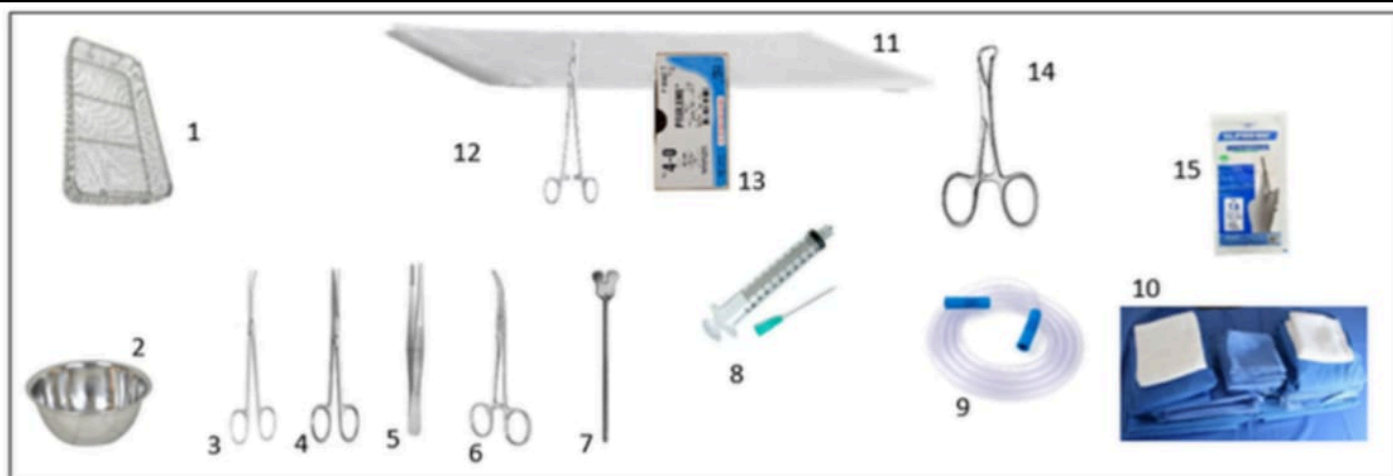


1.3. LISTA DE CHEQUEO:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
- o Canasta de Plastia - o Sonda acanalada	- Paquete de ropa - Hoja #11 - Catéter de 30 cm calibre 14 - Jeringa 50 ml - Sonda foley 18Fr - Guantes - Gasas - Electrobisturí - Cistoflo - Jeringa 10 ml - Caucho de succión - Micropore	Piel: Polipropileno 3/0 con aguja $\frac{3}{8}$ de círculo cortante con aguja de 27 mm	Solución salina Lidocaína 1% Agua esteril (balón de sonda foley)

• ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

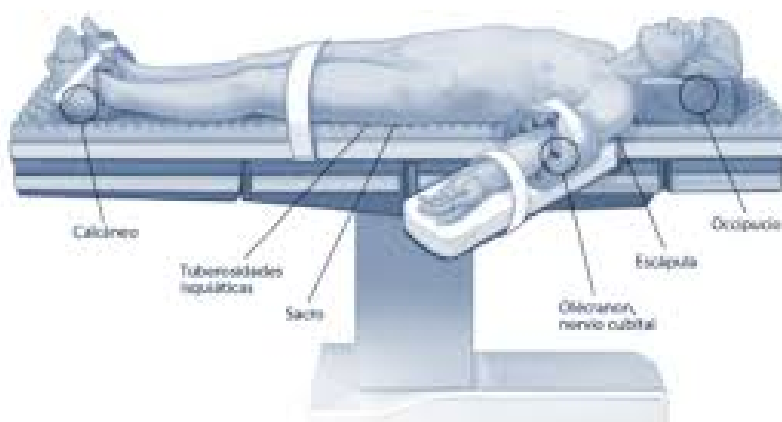
- o **ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).**



1. Canasta Infantil. 2. Coca con solución salina. 3. Tijera de Metzembraum. 4. Tijera de mayo. 5. Pinzas de disección. 6. Pinza Kelly Curva. 7. Sonda Acanalada. 8. Jeringa de 10cc. 9. Caucho de succión. 10. Paquete de Ropa. 11. Compresa. 12. Portaagujas. 13. Suturas. 14. Pinza de Campo. 15. Guantes.

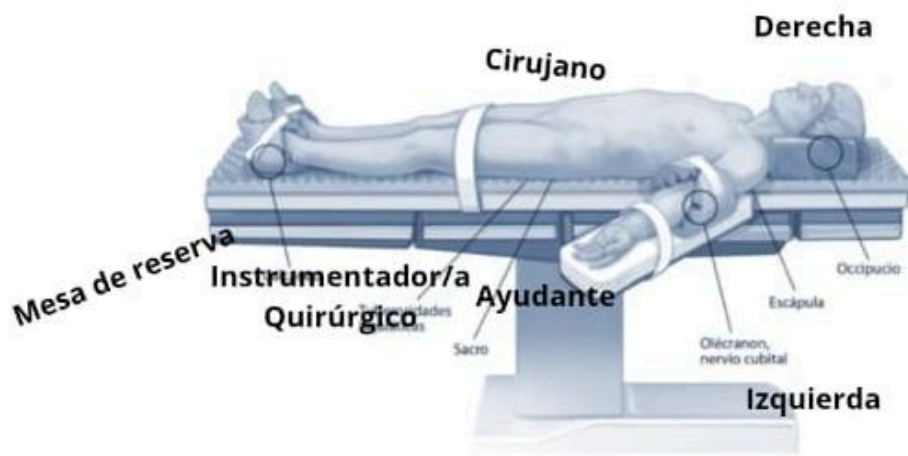
2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

Decúbito supino + Rodillo de sabana bajo la cadera





2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):



• **ETAPA DE EJECUCION:**

- **ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA):** Anestesia general



- **INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):**
Se realiza una incisión supra púbica infra abdominal transversal de 2-3cm
- **PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Se hace una incisión de 2-3 cm en la región suprapúbica de manera transversal	Mango de bisturí #3 Hoja de bisturí #11
Se introduce el catéter a través de la incisión, con una inclinación caudal de 60°	Catéter calibre 14 Jeringa de 50cc
Se atraviesa la aponeurosis y penetr en la vejiga distendida, se aspira orina para comprobar que la punta de catéter haya penetrado la vejiga	
Se divulsionan las capas del tejido hasta llegar a la pared de la vejiga, se coloca la sonda acanalada sobre la sonda Foley para permitir el paso de esta	Sonda Acanalada Sonda Foley



Estando colocada la sonda Foley se infla el balón de esta con agua estéril	Sonda Foley Agua Estéril
Se fija la sonda a la piel para asegurar su posición, se sutra alrededor a la incisión para proteger la entrada y evitar el riesgo de infección	Polipropileno 3/0 cc 3/8 de circulo
Se conecta la sonda Foley con el cystoflo, se verifica retorno, se clampea bolsa de drenaje urinario	Cystoflo
Se hace limpieza del sitio operatorio y curación	Gasas Micropore
FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA <u>IQX-FT-024-UDES</u>	



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01